

Religijny *kontekst* PPU

Religia i duchowość mogą być źródłem ogromnego wsparcia lub ogromnego cierpienia w PPU. Karta dla osób, dla których wymiar duchowy jest częścią problemu — i częścią rozwiązania.

CZAS: 45 min refleksja Po identyfikacji MI

ŹRÓDŁO: Grubbs (2019); Sanchez i wsp. (2024); Pargament (2007)

JAK UŻYWAĆ

Karta zwraca się do osób, dla których **religijne lub duchowe wartości** są istotne i wchodzą w konflikt z zachowaniem PPU. Karta przedstawia: 1) *jak religia wzmacnia / łagodzi PPU*, 2) **4 wzorce** relacji z duchowością w PPU, 3) *zdrowa* integracja religii z terapią, 4) rola duchownego / terapeuty / wspólnoty wiary.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Grubbs i wsp. (2019) wykazali, że **religijność** nie jest sama w sobie ani czynnikiem ryzyka, ani ochronnym dla PPU — *zależy od typu religijności*. Religijność **zdrowa** (oparta na łasce, miłosierdziu, współnocie) działa *ochronnie*. Religijność **toxic** (oparta na strachu, karze, izolacji) *wzmacnia* cykl wstydu i PPU. Sanchez i wsp. (2024) w 5-letnim badaniu kontrolnym (ang. *follow-up*): pacjenci, którzy *zintegrowali* wymiar duchowy z terapią (rozmowa z duchownym, świadoma teologia, wspólnota wsparcia) — mieli **40-60% wyższą stabilność** długoterminowej zmiany niż pacjenci ignorujący ten wymiar. Karta *nie* namawia ani do religii, ani od niej — pomaga osobom religijnym *twórczo* pracować z tym wymiarem.

01

Religia w PPU — kiedy pomaga, kiedy szkodzi

POMAGA, GDY...

- Daje **wspólnotę wsparcia** (grupa, wspólnota, duchowny)
- Buduje **autentyczne wartości** (nie z lęku, z miłości)
- Oferuje **narzędzia duchowe** (medytacja, modlitwa, spowiedź)
- Daje **poczucie sensu** wykraczające poza problem
- Pielęgnuje **łaskę** — możliwość powrotu po upadku
- Łączy abstynencję z **pozytywnym celem**

SZKODZI, GDY...

- Karze **strachem przed potępieniem**
- Izoluje od wsparcia („*nie mów nikomu*”)
- Każe **walczyć w pojedynkę** z grzechem
- Demonizuje seksualność *całkowicie*
- Uniemożliwia rozmowę z duchownym (wstyd)
- Buduje **perfekcjonizm** niezgodny z biologią ciała
- Wzmacnia **spirale wstydu** przy każdym upadku

02

= Cztery wzorce relacji z duchowością

1 · INTEGRACJA ZDROWA

Wiara + terapia + wspólnota = synergia. Pacjent łączy modlitwę z technikami CBT, spowiedź z autosympatią. Najlepszy długoterminowy wynik.

2 · RELIGIJNOŚĆ TOXIC

Wiara jako bicz na siebie. Spowiedź → wstyd → potrzeba ulgi → porno → spowiedź. Cykl wzmocniony. Wymaga rekonstrukcji teologii (duchowny + terapeuta).

3 · ODRZUCENIE RELIGII

Pacjent porzucił wiarę w młodości, ale internalizowane przekonania pozostają i wywołują wstyd. Wymaga świadomej pracy nad „resztkami” religijnymi.

4 · DUCHOWOŚĆ ŚWIECKA

Wartości głębokie bez religii instytucjonalnej. Medytacja, etyka, sens. Często skuteczna integracja z ACT (wartości).

03 ● Zasady zdrowej integracji religii z terapią

1. Wybierz duchownego, który zna PPU jako problem kliniczny, nie tylko moralny. Współpraca z terapeutą.

2. Zastąp samokarę autosympatią opartą na łasce. „Bóg mi przebacza, ja sobie nie przebaczam” jest absurdem.

3. Modlitwa **jako** uzupełnienie terapii, nie zastępstwo. Bóg pomaga przez ludzi — terapeuta jest narzędziem.

4. Spowiedź — sakrament uzdrowienia, nie tylko deklaracja grzechu. Jeśli wywołuje wstyd toxic — porozmawiaj z duchownym.

5. Wspólnota wiary jako sieć wsparcia, nie miejsce wstydu. Grupy męskie, kierownictwo duchowe, mentorstwo.

6. Akceptacja biologii ciała. Seksualność jest darem, popęd jest naturalny. Problem to *nieuporządkowanie*, nie sam popęd.

04 ✎ Twoja praca z wymiarem duchowym

MÓJ WZORZEC RELACJI Z DUCHOWOŚCIĄ

— 1, 2, 3 czy 4 (lub mieszany)

CO W MOJEJ WIERZE POMAGA W PRACY NAD PPU

— konkretne elementy

CO W MOJEJ WIERZE SZKODZI (JEŚLI COŚ)

— przekonania toxic

Z KIM MOGĘ POROZMAWIAĆ

— duchowny, mentor, terapeuta

Klucz: Pargament (2007, „*Spiritually Integrated Psychotherapy*”) podkreśla, że **wymiar duchowy jest dla wielu pacjentów fundamentalny** i ignorowanie go w terapii jest *poważnym brakiem*. Jednocześnie: terapeuta nie powinien *narzucać* swoich poglądów religijnych ani *odradzać* wiary. Praca z wymiarem duchowym to **respektowanie autorytetu pacjenta** — pomoc w zobaczeniu, co dla niego/-j znaczy, co działa, co szkodzi. W PPU specyficznie: pacjenci religijni z ciężkim cyklem wstydu często potrzebują *rekonstrukcji teologii* (przejścia od „bóg karzący” do „bóg miłosierny”) — i to często wymaga współpracy duchownego z terapeutą.